

Fecha Última Actualización: 02-08-2022 15:48:52

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Juan Luis Silva Contreras
Edad : 71a 1m 10d
Dirección : Ejercito Libertador 3651

Rut : 6.281.891-3
Fecha Nacto: 23/06/1951
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1719125
Sexo : Masculino
Teléfono : 2 2318 3068

N° Epicrisis
317604

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 19/06/2022 20:41

Días Estadía: 44

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 02/08/2022 15:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

PANCREATIRIS GRAVE

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente sin antecedentes mórbidos , ingresa en condiciones de extrema gravedad desde Urgencia HSR.
A las 05 de la madrugada del 20/06/2022 comienza con dolor lancinante y terebrante en epigastrio, de forma súbita, irradiado a todo el abdomen y el tórax, acompañado de náuseas y vómitos no explosivos más bien de carácter bilioso. .
Se diagnostica en forma clínica pancreatitis aguda.

PAN ANGIOTAC TORAX-ABDOMEN-PELVIS (20/6/22):

Impresión.

- 1.-Hallazgos compatibles con pancreatitis aguda en evolución con signos de necrosis del parénquima pancreático en la cola que compromete aproximadamente un 20-30% considerando que no se dispone de fase tardía.
- 2.-Colecciones no organizadas peri pancreática, estables en comparación a estudio de 19 de junio.
- 3.-Signos de trombosis no oclusiva de la vena esplénica.
- 4.-Leve a moderada ascitis que predomina en excavación pelviana la cual ha aumentado en comparación a estudio previo.
- 5.-Derrame pleural bilateral de leve mayor cuantía que en estudio previo.
- 6.-Colelitiasis.
- 7.-Esteatosis hepática difusa.
- 8.-Ateromatosis cálcica aorto-coronaria

Se inicia reanimación con volumen cristaloide y queda hospitalizado en Urgencia HSR.

Evoluciona en forma tórpida se pide evaluación por Cirugía HSR:

* 2° día de colecisto-pancreatitis aguda Balthazar E, con descompensación hemodinámica.

Sin indicación quirúrgica actual dado gravedad.

Se sugiere IC a cirugía Hepatobiliar una vez estable del punto de vista hemodinámico para seguimiento.

Paciente evoluciona con mala mecánica respiratoria, signos de fatiga muscular, se decide IOT y posteriormente se traslada a UCI , donde evoluciona con shock septico severo inicial , posteriormente se evidencian en imagenes de control multiples colecciones , en este contexto es llevada a pabellón el día

11-7 -22 evidenciando una peritonitis difusa mas colección en la raiza del meso que es drenada dando salida a 2 lts de liquido turbio , además se realiza necrosectomia de la cola de pancreas , queda con 2 drenajes . Salea UCI donde se mantiene con terapia AB según gérmenes aislados

El paciente evoluciona tórpidamente , con requerimientos amntenidos de avsoactivos y parámetros inflamatorios elevados , el día 31-7 se realiza imágenes de control que evidencian

Progresión en signos de extensa pancreatitis necrohemorrágica, con progresión de la necrosis intrapancreática y desarrollo de

Fecha Epicrisis : 02/08/2022 15:48

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 02-08-2022 15:48:52

Página 2 de 2

prominente colección con signos de extravasación activa del medio de contraste en ubicación subhepática. Sangrando de la pancreática, sin claridad que sea la arteria.

Va a embolización.

Estabilidad de restantes múltiples colecciones organizadas.

Disminución de calibre de arteria hepática izquierda y en de la porta principal.

Aumento de derrame pleural bilateral

Posterior a embolización evoluciona con shock séptico refractario falleciendo el día 1.8.22 a las 15:20, se informa a familiares.

POSIBLES CAUSAS:

Arritmia ventricular compleja

Fallo multiorgánico

Shock Séptico a foco Peritonitis difusa

Pancreatitis Grave

Diagnóstico de Egreso

Shock séptico - PANCREATITIS GRAVE + PERITONITIS DIFUSA + FALLO MULTIORGANICO

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIDO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Juan Ulloa Mancero
Médico Tratante (Staff)